

الوباء الصامت في ليبيا: السيطرة على ارتفاع ضغط الدم أفضل استثمار أول لمواجهة الأمراض غير السارية

تسبب الأمراض غير السارية 76% من عبء المرض في ليبيا. لم تنخفض الوفيات المبكرة الناجمة عنها منذ عام 2000، وليبيا ليست على المسار الصحيح لبلوغ هدف التنمية المستدامة لعام 2030. والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم تدخل ميسور التكلفة ومثبت الفعالية وسريع التوسع.

1,949\$

لكل سنة عمر صحية مكتسبة

11%

من مرضى الضغط ضغطهم تحت السيطرة

19.8%

احتمال الوفاة المبكرة بين 30 و 70 سنة (2021)

76%

من عبء المرض سببه الأمراض غير السارية (2022)

الرسائل الرئيسية

- ما يقارب واحداً من كل خمسة ليبيين في سن الثلاثين سيتوقى بأمراض القلب أو السرطان أو السكري أو أمراض الرئة المزمنة قبل بلوغ السبعين (19.8% في 2021، مقابل 20.0% في 2000).
- يعاني 42.7% من البالغين (30-79 سنة) من ارتفاع ضغط الدم، أي نحو 1.5 مليون شخص. 52% منهم لا يعلمون بإصابتهم، و11% فقط ضغطهم تحت السيطرة.
- المال ليس العائق الأساسي: ليبيا الأعلى إنفاقاً على الصحة للفرد بين دول الجوار في شمال أفريقيا (470 دولاراً)، لكن هذا الإنفاق يتقلب بشدة من سنة إلى أخرى.
- رفع نسبة السيطرة إلى 50% يكلف نحو 1,949 دولاراً لكل سنة عمر صحية مكتسبة، وهو أقل بكثير من نصيب الفرد من الناتج المحلي (6,027 دولاراً).

١. المشكلة

الأسباب الرئيسية لعبء المرض في ليبيا، 2022 (% من سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة)



أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأول لاعتلال الصحة في ليبيا (20.9% من إجمالي سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة)، و91% من هذا العبء سببه الوفاة المبكرة. وتسجل ليبيا أعلى المعدلات بين دول الجوار في شمال أفريقيا في السكري (28%) وارتفاع ضغط الدم (42.7%) وقلة النشاط البدني (46%)، ويعاني ثلث البالغين من السمنة (34%). وبلوغ الهدف 3.4 من أهداف التنمية المستدامة (خفض الوفيات المبكرة بمقدار الثلث بحلول 2030، أي إلى 13.6%)، تحتاج ليبيا إلى خفض هذا المعدل بنسبة 4.1% سنوياً، بينما لا تتجاوز الوتيرة الحالية 0.5%.

٢. فجوة الرعاية

توزيع الليبيين المصابين بارتفاع ضغط الدم (2019):



معظم الخسارة تقع قبل بدء العلاج: نصف المصابين لا يُشخصون أبداً. ويمكن سدّ هذه الفجوة في الرعاية الصحية الأولية بأدوات بسيطة: جهاز قياس الضغط، وبروتوكول علاجي موحد، وإمداد منتظم بالأدوية.

د. نذير يونس سليمان

طبيب • محلل بيانات صحية

٣. لماذا الآن

عبء الأمراض غير السارية في ليبيا يتزايد باستمرار، وكل بضع سنوات تأتي صدمة جديدة فوقه. فقد بلغ العنف 21% من إجمالي العبء في 2011، ورفعت جائحة كوفيد-19 نسبة التهابات الجهاز التنفسي إلى 21% في 2021، وتضاعف عبء الإصابات نحو 9 مرات في 2023، عام فيضان درنة. ومرضى الضغط والسكري غير المسيطر عليهم هم الأكثر تضرراً عند انقطاع الخدمات. والإنفاق الصحي للفرد هو الأعلى بين دول الجوار (80% منه تمويل حكومي و19% من جيب المواطن)، لكنه يتقلب بشدة من سنة إلى أخرى (الانحراف المعياري للتغير السنوي نحو 28%)، لذا تحتاج البرامج طويلة الأمد إلى تمويل محمي.

٤. مبررات الاستثمار

قدّرنا أثر رفع نسبة السيطرة على الضغط من 11% إلى 50% من المصابين خلال خمس سنوات:

≈ 64,353	≈ 5,913	145 مليون \$	≈ 586 ألف
سنة عمر صحية مكتسبة	جلطة قلبية وسكتة دماغية يتم تجنبها	على 5 سنوات (≈ 29 مليون سنوياً)	شخص إضافي ضغطه تحت السيطرة

صافي التكلفة 1,949 دولاراً لكل سنة عمر صحية مكتسبة (نطاق عدم اليقين 5,321-646 دولاراً)، واحتمال أن يكون البرنامج فعالاً من حيث التكلفة عند عتبة نصيب الفرد من الناتج المحلي 99%. وهذه تقديرات متحفظة، لأنها تحتسب خمس سنوات فقط، ولا تحتسب من الوفورات إلا تكاليف علاج الحالات الحادة التي يتم تجنبها.

٥. التوصيات

- اعتماد بروتوكول علاجي وطني موحد وبسيط في الرعاية الأولية، قائم على حزمة HEARTS لمنظمة الصحة العالمية: أدوية مركبة بجرعات ثابتة، ورعاية جماعية بمشاركة التمريض والصيدالة.
- الوصول إلى النصف غير المشخص بقياس الضغط في كل زيارة للرعاية الأولية وفي الصيدليات، وتنظيم حملات كشف سنوية.
- حماية إمداد الأدوية بهند ميزانية مخصص وشراء مجمع لأدوية الضغط والسكري الأساسية، حتى لا يتأثر الإمداد بتقلبات الميزانية.
- قياس ما يهم بإجراء مسح وطني جديد لعوامل الخطر (STEPS)، وإنشاء سجل بسيط لمرضى الضغط، واعتماد نسبة السيطرة مؤشراً وطنياً.
- ضمان استمرارية الرعاية في الأزمات بإدراج مخزون أدوية الأمراض المزمنة وقوائم المرضى في خطط الطوارئ الخاصة بالنزاعات والأوبئة والفيضانات.

عن هذا التحليل

البيانات: المرصد الصحي العالمي لمنظمة الصحة العالمية (2000-2024)، ودراسة العبء العالمي للمرض 2023 (IHME، 2024)، والتوقعات السكانية للأمم المتحدة 2024، مع المقارنة بتونس والجزائر ومصر والمغرب. يعتمد النموذج الاقتصادي على تكاليف منشورة (حزمة HEARTS، ودراسات مستشفيات مغربية) وعلى أثر علاجي منشور (Ettehad وزملاؤه، Lancet 2016)، مع تحليل حساسية احتمالي بخمسة آلاف محاكاة. التقديرات نمذجة تنطوي على قدر كبير من عدم اليقين، ولا يزال أحد المدخلات (تكاليف إدارة البرنامج) افتراضياً. الكود والبيانات والمنهجية: github.com/natheerne-hub/libya-ncd-burden

د. نذير يونس سليمان
طبيب • محلل بيانات صحية
github.com/natheerne-hub/libya-ncd-burden